

Jeg er ikke et eksempel

En pasients undersøkelse av hva vi egentlig vet om et langt liv

FREDDY BREMSETH

PRØVELESEEKSEMPLAR

Essayversjon v5, august 2026

© 2026 Freddy Bremseth

Om dette prøveleseeksemplaret

Dette prøveleseeksemplaret inneholder et sammenhengende utdrag fra begynnelsen av Jeg er ikke et eksempel. Det bygger på utgaven som er angitt på forsiden. Teksten nedenfor er hentet fra manuskriptet og er ikke hele boken.

Utdragets lengde: ca. 5,176 ord.

Om denne utgaven

Dette er versjon 5 av Jeg er ikke et eksempel, ferdigstilt som essayversjon i august 2026.

Boken kombinerer personlig historie med en kildebasert undersøkelse av hva helseforskning kan — og ikke kan — fortelle om et langt og funksjonelt liv.

Forfatteren er ikke helsepersonell. Når teksten omtaler sykdom, måltall, prøver, legemidler eller behandling, beskriver den forskning, retningslinjer eller forfatterens egen historie. Den erstatter ikke en individuell medisinsk vurdering.

Studier beskriver grupper. Retningslinjer endres. Et behandlingsmål eller en undersøkelse som er riktig for én person, kan være feil eller unødvendig for en annen.

Kildene er oppdatert frem til august 2026 der opplysningene er tidsavhengige. Leseren bør bruke boken som kunnskap og bakgrunn for spørsmål — ikke som grunnlag for å starte, endre eller avslutte behandling.

Innhold

Forord 4

Prolog: Ikke mas 9

DEL I — RAMMEVERKET 21

1 Hva som faktisk kommer til å ta deg 22

2 Levetid er ikke det samme som helsetid 27

3 Hvordan lese en helsepåstand 31

4 Rangeringen 45

DEL II — DE STORE SPAKENE 54

- 5 Kondisjon 55
- 6 Styrke 63
- 7 Blodtrykk 71
- 8 Metabolsk helse 81
- 9 Lipider 91
- 10 Søvn 100
- 11 Kosthold 110

DEL III — HJERNEN, SINNET OG DE ANDRE 119

- 12 Demens 120
- 13 Sosiale relasjoner 127
- 14 Formål, stress og psykisk helse 134
- 15 Tobakk, alkohol og eksponeringer 142

DEL IV — MEDISIN, MÅLING OG MARKED 150

- 16 Hva som kan måles, og hva jeg ikke hadde målt 151
- 17 Screening og overdiagnostikk 162
- 18 Medikamenter som faktisk virker 169
- 19 Anti-aldringsindustrien 181

DEL V — Å FÅ DET GJORT 188

- 20 Hvorfor kunnskap ikke er nok 190
- 21 Strukturen som virker 198

Forord

Hva slags bok dette er

Datteren min er halvannet år.

Sønnen min blir født om en uke.

Jeg er femtiseks.

Det er et regnestykke jeg gjør oftere enn jeg liker å innrømme. Når Victoria fyller tjue, er jeg syttifire. Når Andreas fyller tretti, er jeg seksogåtti.

Det er den ærlige grunnen til at jeg har brukt et år på å lese meg gjennom helseforskning.

Det som skjedde

Jeg var førtiseks år og én dag da jeg fikk hjerneslaget.

Én dag etter bursdagen min. Jeg hadde nettopp blåst ut lys.

Det korte er dette: et blodtrykk langt utenfor det kroppen min tålte, en telefonsamtale med en offentlig etat som endte med at jeg la på røret, et brudd på et fjell, elleve dager der ingen behandlet meg, og en kveld i en sofa der jeg ikke klarte å legge en fjernkontroll på et bord.

CT og MR viste hjerneslag.

Det er ti år siden.

Det jeg tok med meg fra den perioden, var ikke en oppvåkning. Jeg vil advare mot den fortellingen med en gang, for den er den vanligste løgnen i denne sjangeren. Jeg brukte flere år etter slaget på å gjøre omtrent de samme tingene som før, bare litt reddere.

I dag veier jeg hundre kilo. Blodtrykket mitt er ikke i mål på to medisiner. Jeg har en tannskinne mot søvnapné som ligger i en skuff, et høreapparat jeg bruker noen ganger, en brillerecept jeg aldri fikk til å bli en vane, og blodprøver som er tatt og aldri lest.

Det er utgangspunktet mitt. Det er verdt å vite før du leser videre.

Hva denne boken er

Dette er en essaybok om hvordan en pasient forsøkte å forstå helseforskning.

Den er ikke en veiledning. Den forteller deg ikke hva du skal gjøre for å leve lenger, og den kan ikke det.

Det jeg gjør, er å ta ett tema av gangen — blodtrykk, kondisjon, søvn, kosthold, demens, legemidler — og undersøke hva som faktisk står i forskningen, hvor sikkert det er, hvem det gjelder for, og hvor jeg selv tok feil da jeg trodde jeg visste det.

Formen er derfor gjennomgående denne:

«Jeg leste dette.» «Studien fant dette, i denne gruppen, med disse forbeholdene.» «Retningslinjen sier dette.» «Min vurdering er denne, og den er min.»

Ikke: du bør.

Hvorfor jeg skriver det slik

Fordi jeg ikke er lege, og fordi forskjellen betyr noe.

Jeg har lest primærkilder, notert effektstørrelser, og forsøkt å skille det dokumenterte fra det plausible. Det gjør meg til en informert pasient. Det gjør meg ikke kvalifisert til å fortelle et menneske jeg aldri har møtt hva han skal gjøre med kroppen sin.

Forskjellen er ikke formell. Den er praktisk:

Et behandlingsmål avhenger av alder, andre sykdommer, hvilke medisiner du bruker, hva du tåler, og hva som er skjedd med deg før. En retningslinje som gjelder for én gruppe, gjelder ikke for en annen. Et tall som er riktig for meg, kan være galt for deg — og motsatt.

Det kan bare avgjøres av noen som kjenner journalen din.

Så: ingenting i denne boken er behandlingsråd. Der jeg gjengir måltall eller anbefalinger, gjengir jeg hva en retningslinje sier — ikke hva du bør gjøre. Hvert medisinske kapittel avsluttes med den samme setningen, og den er ikke en formalitet.

Fire regler jeg har satt for meg selv

Jeg skrev en tidligere versjon av dette manuset som ikke holdt mål. Den var full av setninger av typen «forskning har vist at...» uten at jeg kunne si hvilken forskning. Det er lett å skrive, det høres tillitvekkende ut, og det er ikke godt nok.

Så jeg har gitt meg selv fire regler, og du kan holde meg til dem:

1. Hver forskningspåstand har en kilde med navn, årstall og tidsskrift — og jeg oppgir hvem studien gjaldt for, ikke bare hva den fant.

2. Der jeg tror noe uten å kunne belegge det, sier jeg det rett ut. Jeg skal ikke kle en gjetning i vitenskapelige klær.

3. Jeg presenterer motargumentene. Flere av de mest populære ideene om lang levealder — blant annet blå soner, som jeg selv lot meg begeistre av — har fått alvorlig kritikk. Kapittel 3 tar den saken fra ende til annen, inkludert motargumentene mot kritikerne.

4. Jeg skriver om det som gikk galt. Mine egne feil er ikke pynt. De er halve poenget.

Hva jeg har tatt feil om

Siden regel fire står der, kan jeg like gjerne tømme lommene med en gang.

I den forrige versjonen av dette manuset skrev jeg at moderat rødvin er godt for hjertet. At blå soner var «grundig dokumentert». At ikigai var forskning. At kroppen begynner å forbrenne fett etter tjue minutter. At jeg gikk ned tretti kilo og holdt vekten.

Alle fem var feil.

Underveis i arbeidet med denne boken tok jeg dessuten feil om hvilket land som har innført generasjonsforbud mot tobakk, og om hva norske retningslinjer sier om blodtryksmåling etter hjerneslag.

Jeg lar rettelsene stå i teksten der de hører hjemme, i stedet for å skjule dem. Det er ikke ydmykhet. Det er den eneste måten leseren kan se om metoden virker.

Hvor jeg faktisk er

Vi har kjøpt en olivengård i Biar i Alicante. Vi bor ikke på den. Huset skal tegnes, det skal søkes om tillatelser, det skal bygges, og en bolig i Norge skal selges først.

I mellomtiden leier vi i Benidorm, nær stranden. Det er ikke stillheten vi flyttet for. Det er et sted som fungerer mens vi venter.

Jeg skriver det så tydelig fordi versjonen der noen forlater Norge og våkner neste morgen i en olivenlund, ikke er sann.

Og fordi jeg flyttet til Middelhavet av helsegrunner og gikk opp tjue kilo. Det står i kapittel 11.

Hva jeg håper

Ikke at du gjør noe bestemt. Det er ikke min rolle.

Det jeg håper er mindre og vanskeligere: at du blir litt bedre til å lese en helsepåstand.

Å se forskjell på relativ og absolutt risiko. Å spørre hvem en studie gjaldt for. Å legge merke til når noen forteller deg om overlevelse i stedet for dødelighet. Å kjenne igjen en mekanisme forkledd som et bevis.

Og kanskje, som en bivirkning, at du legger merke til hva du holder på å venne deg til.

For det var det som nesten tok meg. Ikke en enkelt dårlig beslutning, men en lang rekke rimelige valg — én ekstra jobb, én telefon til klokken fire om morgenen, ett blodtrykk jeg kjente til og ikke gjorde noe med.

Jeg oppdaget det ikke selv. Jeg satt i en sofa og forsto ikke en fjernkontroll med tre knapper, og syntes ikke det var rart.

Noen andre måtte se meg.

Freddy Benidorm, august 2026

Om det medisinske innholdet i denne boken Jeg er ikke helsepersonell. Denne boken er en personlig undersøkelse av helseforskning, ikke medisinsk rådgivning. Der jeg gjengir måltall, prøver, legemidler eller behandlingsanbefalinger, gjengir jeg hva en navngitt kilde eller retningslinje sier — på det tidspunktet jeg skrev. Slikt endres, og det gjelder ikke likt for alle. Ingenting her skal brukes til å starte, endre eller avslutte behandling. Det gjelder særlig legemidler, treningsintensitet ved sykdom, og alt som angår mennesker som har hatt hjerneinfarkt, hjerneslag eller annen hjerte- og karsykdom. Har du symptomer, eller er du i tvil: snakk med legen din.

Prolog: Ikke mas

I. Seksti-tre prosent

Jeg var førtiseks år gammel.

Ikke førtiseks og et halvt, ikke «i midten av førtiårene». Førtiseks år og én dag da det skjedde — dagen etter bursdagen min.

Men først må jeg fortelle om telefonen.

Jeg var sykmeldt da den ringte.

Legen hadde målt blodtrykket mitt til 255 over 165. For dem som ikke har noe forhold til de tallene: normalt ligger rundt 120 over 80. Han skrev en legemelding som slo fast at jeg ikke skulle håndtere økonomiske samtaler. Ikke fordi jeg var for opprørt til å tenke klart, men fordi kroppen min ikke tålte det.

Så ringte skatteetaten.

Hun i den andre enden skulle informere meg om at de kom til å trekke tretti prosent av lønnen min i innkreving.

Tretti prosent i tillegg til de trettitre jeg allerede betalte i vanlig skattetrekk.

Jeg gjorde regnestykket mens hun snakket. Seksti-tre prosent av lønnen. Jeg hadde barn, husleie, mat, regninger, en hverdag som allerede var stram. Jeg forklarte det. Jeg sa at det ikke lot seg gjøre — ikke som en forhandling, men som en opplysning, sånn man opplyser om at en bil ikke går på tom tank.

Hun brydde seg ikke. Tonen var ufin på en måte jeg fortsatt husker uten å kunne gjengi ordene.

Så sa jeg det jeg trodde var den fornuftige utveien: at jeg ikke ville ha denne samtalen muntlig. At de måtte ta det

skriftlig. Og jeg forklarte hvorfor — at jeg hadde legemelding på at jeg ikke skulle snakke om økonomi, fordi blodtrykket mitt lå på 255 over 165.

Det var da hun lo.

Hun sa at det ikke kunne stemme. At hvis jeg hadde de tallene, hadde jeg vært dævv.

Jeg la på røret.

Det er alt jeg gjorde. Jeg sa ikke noe tilbake, jeg diskuterte ikke, jeg ba ikke om å få snakke med en leder. Jeg satt med telefonen i hånden i en stille stue og hadde ikke mer å gi.

Jeg vil at du skal legge merke til nøyaktig hva som skjedde i den samtalen, for det er et mønster jeg har møtt igjen og igjen siden — og som jeg tror mange kjenner igjen fra sitt eget liv.

Jeg fortalte en representant for staten en medisinsk opplysning om min egen kropp.

Hun brukte den opplysningen til å kalle meg en løgner.

Og hun hadde delvis rett i premisset. Det er faktisk tall som ligger farlig nær grensen for hva et menneske tåler. Det var jo nettopp derfor legen hadde skrevet meldingen.

Noen måneder senere holdt jeg på å dø av det.

II. Fjellet

Jeg hadde ferie.

Det står det på papiret, i hvert fall. I praksis tok jeg et frilansoppdrag midt i den, fordi jeg trengte inntekten.

Det er den delen jeg har hatt vanskeligst for å skrive, fordi den ikke kler meg. En mann med et blodtrykk på 255 over 165 og en legemelding om at han ikke skal utsettes for økonomiske påkjenninger, som får beskjed om at seksti-tre prosent av

lønnen skal forsvinne, og som løser det ved å ta ekstraarbeid i ferien.

Jeg tenkte ikke på det som usunt. Jeg tenkte på det som å ordne opp. Det var slik jeg alltid hadde løst problemer: en sjåfør ble syk, jeg kjørte ruten selv. Regnskapet måtte gjøres, jeg satte meg ved kjøkkenbordet etter at barna hadde sovnet. Det kom et krav jeg ikke hadde penger til, jeg fant et oppdrag.

Alltid en løsning. Alltid samme løsning: mer av meg.

Oppdraget var å fotografere en hyttebedrift — overnatting, aktiviteter, den slags bilder som skal få en familie i Rotterdam eller Rålingen til å tenke dit vil vi. Sånne oppdrag krever mennesker i bildet. Tomme hytter selger ingenting. Så jeg tok med meg tre av barna mine og brukte dem som modeller.

Det var en av de gode dagene.

Vi var på Hunderfossen. Jeg husker dem i motlys, tre par sko på en trebro, en av dem som snur seg mot kameraet et halvsekund for tidlig og ødelegger bildet på den måten som gjør at man beholder det likevel. Jeg fikk mer enn jeg trengte. Kortet var fullt av bilder jeg allerede visste at kunden kom til å like.

På kvelden gikk vi opp på fjellet. Det var småregn i luften, den typen som ikke er vær engang, bare fuktighet som legger seg på ansiktet og gjør grusen mørkere enn den var. Lyset var i ferd med å gå. Vi gikk oppover en vei i den løse formasjonen barn og voksne alltid faller inn i når ingen har det travelt.

Sønnen min ble hengende litt bak.

Det er ikke noe mer i det enn det. Han gikk saktere, jeg ville se etter ham. Jeg snudde hodet og overkroppen bakover mens jeg fortsatt gikk, og tok noen skritt sidelengs uten å stoppe opp. Man gjør det tusen ganger. Man gjør det hver dag, i en butikk, på et fortau, på vei ut av en heis.

Det jeg ikke visste, var at jeg gikk over en ferist. En hjemmelaget en — sprinkler lagt over en grøft for å hindre sauene i å krysse veien. Ikke en fabrikkvare med tette mellomrom. Noe som var laget av noen som hadde det de hadde.

Venstre fot gikk ned mellom sprinklene.

Foten satte seg fast, og kroppen min var fortsatt i bevegelse. Det er hele forklaringen. Ankelen sto stille, resten av meg fortsatte utover, og bevegelsen stanset av seg selv fordi det ikke var mer bevegelse å hente.

Så kom det et smell. Et høyt, tørt knepp — ikke en lyd jeg kjente igjen fra noe annet, og jeg har hørt den i hodet mange ganger siden. Jeg falt fem centimeter til.

Så knakk det igjen.

Jeg falt lenger ned, og fikk en hånd i bakken. Jeg husker grusen mot håndflaten, små skarpe steiner som presset seg inn i huden, og at jeg holdt meg fast i den som om bakken kunne stikke av. Benet hang ut fra kroppen i nitti grader.

Det jeg husker best fra de neste sekundene er ikke smerten. Det er beslutningen.

Jeg skrek ikke.

Jeg hadde tre barn på veien bak meg, og jeg visste — ikke som en tanke, men som noe kroppen bestemte før hodet rakk å blande seg — at hvis jeg skrek nå, kom de til å bære den lyden med seg lenge etterpå. Så jeg lot være. Jeg pustet gjennom nesen og sa til Kevin, så rolig jeg klarte, om han kunne hjelpe meg opp.

Han var et barn. Han kom.

Så kom det en mann løpende. En nederlandsk turist, en fremmed, en som tilfeldigvis var på den veien den kvelden. Jeg vet ikke hva han het. Jeg har aldri funnet ut av det. Sammen fikk de dratt foten min opp av risten.

Vi rakk det akkurat.

I løpet av sekundene etterpå begynte foten å vokse. Ikke gradvis — den bare fylte seg, som om noen hadde koblet en slange til den. På under et minutt var den dobbelt så stor, formløs, elefantaktig. Skoen strammet så fort at vi måtte få den av med en gang, ellers hadde den ikke gått av i det hele tatt.

Hvis vi hadde brukt ett minutt til på å diskutere hva vi skulle gjøre, hadde foten fortsatt sittet fast i risten.

III. Sykehuset som ikke hadde noen på jobb

Noen kjørte oss ned til sykehuset. Det var sent på kvelden, og det var nesten ingen der.

De trengte ikke mange sekundene på å se at benet var brukket. Det er en av de få gangene i livet der ingen er i tvil om noe. Men røntgenpersonalet var ikke på jobb, og de måtte komme inn.

Vi ventet i nesten to timer.

To timer er ingenting i et sykehuslokale. Det er en kaffemaskin, et TV-apparat uten lyd, noen stoler i en rekke. To timer er noe helt annet når du ligger med et brudd og har tre redde barn ved siden av deg som ikke kan gjøre noe annet enn å se på faren sin.

Det er den delen jeg har tenkt mest på i ettertid. Ikke smerten. Ansiktene deres. Jeg hadde brukt hele dagen på å fotografere de ansiktene i godt lys, smilende, i bevegelse — og nå satt de i plaststoler klokken elleve på kvelden og forsøkte å lese på meg hvor farlig dette var. Jeg vet ikke hvor godt jeg klarte å skjule det. Jeg tror ikke særlig godt.

Røntgen kom til slutt. Bruddet var stygt. Flere steder i foten. Det måtte opereres.

Men jeg hadde spist middag den kvelden, som folk gjør, og da kan de ikke legge deg i narkose. Så det ble gips i stedet, og beskjed om at operasjonen måtte tas hjemme.

Sju timer etter at vi kjørte inn, var vi tilbake på hytta. Vi forsøkte å sove litt. Jeg vet ikke om noen av oss fikk det til.

Neste dag måtte vi hjem, og jeg kunne ikke kjøre. Det ble tog. Seks timer ned til Sandefjord.

Jeg skal ikke bruke mange ord på den turen. Det er ikke mer å si enn at seks timer i et togsete med et ubehandlet, flerdelt brudd i foten er noe av det verste jeg har vært med på, og at jeg satt der med tre barn som fortsatt så på meg. Så jeg satt stille. Toget stoppet der togene stopper. Folk gikk av og på med kofferter og kaffe. Ingen visste noe.

Vi kom frem. Jeg leverte barna til moren deres.

Så la jeg meg på sofaen med benet høyt og ventet på å bli operert.

IV. Elleve dager

En kamerat leverte papirene mine på sykehuset. Jeg kunne ikke gjøre det selv.

Så ventet jeg.

Jeg ringte annenhver dag. Hver gang med det samme spørsmålet: når skal jeg inn? Hver gang med det samme svaret, i forskjellige ordelag.

Ikke mas. Vær tålmodig.

Jeg maste videre. Ikke fordi jeg er utålmodig av natur — jeg hadde drevet et transportfirma i årevis og lært at ting tar tid — men fordi det gjorde så vondt at jeg ikke klarte å tenke på annet. Det er en type smerte som ikke gir deg noe å holde på med. Du kan ikke jobbe deg gjennom den, ikke sove deg

gjennom den. Den bare er der, hele døgnet, og alt du kan gjøre er å ligge stille og la den gå.

Dag elleve så jeg at gipsen hadde begynt å slenge rundt benet. Hevelsen hadde gått ned, og gipsen hadde ikke fulgt med. Den satt ikke lenger fast på noe.

Det var det som fikk meg av gårde. Ikke smerten — den hadde jeg allerede godtatt som en tilstand. Men gipsen var åpenbart ubrukelig, og jeg tenkte at jeg i det minste måtte inn og få skiftet den.

En lege så på meg der inne.

Jeg husker ikke hvordan han så ut. Jeg husker hva som skjedde med ansiktet hans. Han så på benet, så på papirene, og så ble han sint. Ikke irritert — sint. Han spurte, høyt nok til at flere hørte det, hvem som hadde ansvaret for at denne mannen ikke var operert.

Det er den setningen jeg har tatt med meg videre fra hele historien. Ikke smellet på fjellet. Den setningen.

For i elleve dager hadde jeg ringt et sykehus og fått beskjed om at jeg maste. Og i løpet av femten sekunder i et undersøkelsesrom viste det seg at jeg ikke hadde mast. Jeg hadde hatt rett hele tiden, og det eneste jeg hadde manglet var én person som faktisk så på foten.

Han beordret meg rett inn.

Da hadde bruddet begynt å gro. Feil. Så de måtte knekke det opp igjen.

Deretter tre nye dager med benet hevet, i påvente av at hevelsen skulle gå ned nok til at de kunne operere. Så operasjonen: en plate på utsiden av foten, åtte skruer på innsiden.

Ti år senere klarer jeg såvidt å løpe noen meter. Benet grodde aldri helt tilbake til det det var. Det er ikke en

tragedie, og jeg har levd godt med det. Men det er den varige regningen for elleve dager der ingen så på foten.

Og så var det sprøytene.

Fordi jeg var sengeliggende, fikk jeg blodfortynnende injeksjoner for å forhindre blodpropp. Én om dagen, i ti dager.

Jeg tenkte ikke over det. Man tenker ikke over det. Det er en av mange ting som skjer med deg i et system, og du tar den fordi noen med kittel sier at du skal ta den. Jeg husker den lille sprøyten, plasten, den skarpe stikkende følelsen i huden på magen. Jeg husker at jeg krysset av på et ark.

Jeg skriver det her fordi det hører til i rekkefølgen. Jeg vet ikke — og jeg kommer ikke til å late som jeg vet — nøyaktig hvordan denne kjeden henger sammen medisinsk. Det jeg vet, er hva som skjedde og i hvilken orden: en telefon om seksti-tre prosent, et blodtrykk på 255 over 165, et brudd på et fjell, elleve dager uten behandling, en operasjon, ti dager i sengen, ti sprøyter.

Og så en måned til.

V. Kvelden

Det var meg og Kevin hjemme.

Vi hadde spist middag og sett film. En helt vanlig kveld, av den typen som ikke setter seg noe sted i hukommelsen — bortsett fra denne, som jeg kan gå gjennom minutt for minutt ti år etterpå.

Kevin gikk opp for å legge seg. Jeg tok en tur på toalettet og hadde med meg telefonen, sånn alle gjør og ingen innrømmer.

Der oppdaget jeg at jeg mistet fokus på skjermen.

Bokstavene gled fra hverandre. Synet ble tåkete. Jeg husker at jeg blunket noen ganger og flyttet telefonen litt lenger

unna, som man gjør når man er førti-noe og begynner å bli langsynt.

Så tenkte jeg ikke mer på det.

Det er den setningen jeg vil at du skal legge merke til. Så tenkte jeg ikke mer på det. Hvis du bare skal ta med deg én ting fra denne boken, kan det gjerne være den.

Jeg skulle ned i første etasje. Jeg gikk med krykker, med benet i gips. Jeg kjente at jeg var litt svimmel, så jeg satte meg ned og aket meg nedover trappen trinn for trinn, som et barn. Jeg husker treverket mot håndflatene, den lille dunken i hvert trinn.

Jeg tolket det som praktisk. Svimmel mann med krykker i en trapp — sett deg ned. Fornuftig. Jeg var nok fornøyd med meg selv for å ha tatt den vurderingen.

Nede åpnet jeg kjøleskapet for å ta noe å drikke.

Boksen falt rett ned på gulvet.

Jeg bøyde meg og forsøkte å plukke den opp, men jeg fikk ikke tak. Hånden lukket seg ikke om den. Den gled unna, eller jeg grep ved siden av — jeg klarer ikke helt å rekonstruere hvilken av delene. Jeg forsøkte et par ganger, og så ga jeg opp.

Ga opp. Bare det.

Jeg merket at jeg var desorientert, og jeg brukte ikke noen krefter på å forstå hvorfor. Det er det underligste med hele kvelden, og det jeg har hatt vanskeligst for å forklare til folk etterpå: nysgjerrigheten var borte. Jeg er et menneske som har brukt hele livet på å ville forstå hvordan ting henger sammen. Den kvelden sto jeg på et kjøkkengulv, ute av stand til å ta opp en boks, og registrerte det omtrent som man registrerer at det regner ute.

Jeg satte meg i sofaen.

Jeg plukket opp fjernkontrollen til Apple TV. Den har tre knapper. Et barn på fire skjønner den.

Jeg satt og så på den lenge.

Jeg forsto ikke hvordan den skulle brukes. Ikke som i «jeg husker ikke hvilken knapp» — jeg forsto ikke hva gjenstanden var til. Den lå i hånden min, glatt og lett, og betydde ingenting.

Så skulle jeg legge den fra meg på bordet ved siden av sofaen. Den falt ned på gulvet. Jeg hadde bommet på avstanden.

Jeg tok den opp og forsøkte igjen. Den falt ned igjen.

Tredje gang falt den også.

Da ga jeg opp den også, og ble bare sittende.

Det er den detaljen jeg av og til drømmer om. Ikke ambulansen. En mann i en sofa som prøver tre ganger å legge en fjernkontroll på et bord, og som ikke stusser over at det ikke går.

VI. Har du drukket?

Samboeren min kom hjem.

Hun så på meg, og hun spurte om jeg hadde drukket.

Det var ikke urimelig. Jeg satt skjevt i en sofa, med blikket et sted, og hadde ikke reagert da hun kom inn.

Jeg skulle si nei.

Jeg husker helt tydelig at jeg hadde ordet. Det lå der. Nei. Jeg vet nøyaktig hva jeg mente å si, og jeg vet at jeg åpnet munnen for å si det.

Det som kom ut var lyder. Ikke ord — noen enkle, rare lyder som ikke hørte hjemme noe sted.

Det var det første øyeblikket den kvelden der noe i meg ble redd.

Hun gikk opp og hentet Kevin. Hun spurte om det hadde skjedd noe. Han sa at alt hadde vært fint, at han hadde vært på rommet sitt i en halvtime.

En halvtime. Så lenge hadde det holdt på.

Jeg gjorde noen tegn med hånden.

Og Kevin forsto.

Han forsto at jeg ville skrive.

Jeg vil at det skal stå alene på siden, for det fortjener det: Kevin er sønnen min. Han er også gutten som fikk en diagnose tidlig, og som gjennom hele oppveksten møtte voksne som senket taket for hva han kom til å få til. Jeg har sittet i mange møterom med små stoler og hørt folk forklare meg hva han sannsynligvis ikke kom til å klare.

Den kvelden sto han på et stuegolv, foran en far som ikke kunne snakke, og var den eneste i rommet som skjønnte hva jeg forsøkte å si.

Han hentet blyant og papir.

Jeg fikk hånden rundt blyanten. Jeg kjente treverket, den sekskantede formen mot fingrene.

Og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med den.

Det er ikke det at jeg ikke fant ordene. Det er at selve handlingen var borte — den lille motoriske selvfølgeligheten man lærer når man er fem år gammel og aldri tenker på igjen. Jeg satt med en blyant i hånden og et ark foran meg, og jeg klarte ikke å bevege den. Jeg forsto ikke hvordan skriving foregikk.

Det var da de ringte etter ambulansen.

VII. Sirener

Vi kjørte med full sirene.

Legen i bilen snakket direkte med sykehuset mens vi kjørte, og ga meg forskjellige ting underveis. Jeg vet ikke hva. Bilen kastet seg fra side til side i en fart jeg ikke hadde vært i tidligere, og jeg lå fastspent og hørte stemmen hans over meg, rolig og hurtig på samme tid.

Da vi kom frem, sto det et team på seks personer og ventet.

De løp med meg inn. Bokstavelig talt løp, med bårn, gjennom en korridor, akkurat slik jeg hadde sett det på film uten noen gang å tro at det faktisk foregikk sånn.

Og så, i løpet av noen intense minutter, begynte det å komme tilbake.

Først en lyd som lignet på et ord. Så et ord. Så flere.

Alarmen var over.

CT og MR viste hjerneslag.

VIII. Etterpå

Jeg har fortalt denne historien noen ganger siden, og jeg har lagt merke til at folk venter på et bestemt sted i den. De venter på øyeblikket der jeg forsto.

Det finnes ikke.

Jeg forsto ingenting den kvelden. Det er hele poenget. Jeg hadde tåkesyn på et bad og tenkte ikke mer på det. Jeg var svimmel i en trapp og syntes jeg håndterte det fornuftig. Jeg klarte ikke å plukke opp en boks og ga opp. Jeg forsto ikke en fjernkontroll med tre knapper og ble bare sittende. Det tok en annen person, som kom inn døren og så på meg, før noen i det hele tatt registrerte at det pågikk et hjerneslag.

En hjerne som svikter, mister også evnen til å legge merke til at den svikter. Det er den mest ubehagelige lærdommen jeg har fra dette, og den gjelder langt utover slag: du kan ikke stole på at kroppen varsler deg selv. Noen andre må se deg.

Den andre lærdommen er verre, fordi den ikke handler om biologi.

Faren min falt en gang fra en stige mens han malte huset. Han havnet på sykehus med alvorlige smerter i ryggen. Noen dager senere var han tilbake på jobb i kantinen på Electrolux, fordi en kantine ikke stopper bare fordi eieren ligger. Han hadde helseproblemer sent i livet som ville rettferdiggjort en hvilken som helst mengde klaging, og han klaget så godt som aldri.

Jeg har alltid beundret det. Jeg beundrer det fortsatt.

Men jeg har også sett hva det koster. Faren min hadde ikke noe annet språk å ta av. Å tie var ikke bare styrke — det var det eneste alternativet han hadde fått med seg.

Og så står jeg der, en generasjon senere.

Først i en stue med en telefon i hånden, der jeg forteller en representant for staten hva legen har målt på meg, og får høre at det ikke kan stemme, for da hadde jeg vært død.

Så på en grusvei på et fjell over Lillehammer, med et ben som henger i nitti grader ut fra kroppen, der det første jeg bestemmer meg for er å ikke skrike.

Så på en sofa i elleve dager med et ubehandlet brudd, der beskjeden er at jeg maser.

Tre ganger på noen få måneder ble jeg fortalt — av en etat, av meg selv, av et sykehus — at min egen smerte var overdrevet.

Alle tre tok feil.

Ikke mas. Vær tålmodig.

Jeg vet ikke, og jeg kommer aldri til å vite med sikkerhet, nøyaktig hvordan blodtrykket, de elleve dagene, operasjonen, immobiliteten og alt som fulgte henger sammen med det som skjedde i hodet mitt noen uker senere. Jeg er ikke lege, og jeg skal ikke kle en gjetning i vitenskapelige klær. Journalene mine sier det de sier, og jeg kommer tilbake til dem senere i boken.

Men jeg vet dette: kroppen min hadde i mange år vært et sted jeg lagret ting jeg ikke hadde tid til å ta stilling til. Arbeidsdager som ikke sluttet. Telefoner klokken fire om morgenen. Femti flyreiser i året. Regnskap ved kjøkkenbordet ved midnatt. Et blodtrykk jeg kjente til og ikke gjorde noe med. En ferie jeg fylte med betalt arbeid fordi staten skulle ha seksti-tre prosent. Og en grunnleggende, arvet overbevisning om at egen smerte er noe man ikke skal belaste andre med.

Elleve dager på en sofa var ikke årsaken til noe alene. De var slutten på en veldig lang liste.

Denne boken begynte som et spørsmål om hvordan mennesker kan leve lenge. Den begynner her, med en mann som ikke klarte å legge en fjernkontroll på et bord, og med en gutt på et stuegulv som forsto hva faren hans prøvde å si når ingen andre gjorde det.

Alt det andre — olivenolje, søvn, sol, bevegelse, Middelhavet — kommer etterpå.

Dette kommer først.

Fortsett å lese

Du har kommet til slutten av prøveleseeksemplaret fra Jeg er ikke et eksempel. Hele verket fortsetter utover dette utdraget.